

GUÍA CLÍNICA



Recursos Terapéuticos para el Duelo Infantil

20 actividades clínicas listas para la sesión

Niños de 4 a 10 años · Duelo por la pérdida de un progenitor o familiar cercano

20 recursos terapéuticos para el uso directo en sesión con niños en duelo. Cada actividad se apoya en la literatura clínica sobre duelo infantil —los modelos de Worden y Bowlby y la perspectiva de la ludoterapia— y contempla los distintos momentos del proceso: del duelo reciente a la resignificación y el cierre terapéutico.

Los recursos varían en formato (dibujo, juego, escritura, arcilla, dramatización, narrativa) y en demanda, para que el terapeuta elija y adapte según la fase, la edad y las necesidades específicas de cada niño.

Cada recurso es autosuficiente; el orden es orientativo, no obligatorio.

Modelo de Worden

Teoría del apego (Bowlby)

Ludoterapia

Terapia narrativa

Índice de recursos



Cada recurso incluye objetivo, pasos de aplicación, lectura clínica, preguntas orientadoras y adaptaciones.

- 01 **La Caja de Recuerdos** — Objeto de transición y vínculo simbólico
- 02 **El Mapa de la Añoranza** — Territorios emocionales del duelo
- 03 **El Juego de los Globos** — Dejar ir sin olvidar
- 04 **Carta para Quien Se Fue** — Comunicación simbólica y despedida
- 05 **La Línea de Tiempo de la Vida Compartida** — Integrar recuerdos y ambivalencia
- 06 **El Tribunal de las Emociones** — Dar nombre a lo que pesa
- 07 **El Libro de [Nombre]** — Construir una narrativa viva
- 08 **El Termómetro del Duelo** — Monitorear el proceso
- 09 **El Juego del Antes y el Después** — Reorganización familiar tras la pérdida
- 10 **Lo que Queda Dentro de Mí** — Legado y continuidad del vínculo
- 11 **La Silla Vacía** — Conversar con quien ya no está
- 12 **El Diario de lo que Siento** — Registro semanal del duelo
- 13 **El Ritual de Buenas Noches** — Estructurar el cotidiano del duelo
- 14 **El Juego de la Verdad sobre la Muerte** — Deshacer mitos
- 15 **El Árbol de la Familia** — Quién sigue estando
- 16 **La Escultura del Duelo** — El cuerpo que siente
- 17 **La Historia que Me Cuento** — Narrativa protectora
- 18 **El Panel del Enojo** — Dar forma a lo que quema
- 19 **Conversaciones con Quien Quedó** — Orientación clínica al progenitor sobreviviente
- 20 **El Regalo del Pasado** — Cerrar un ciclo terapéutico

TIPO	Actividad expresiva con un objeto concreto
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo por la pérdida de un progenitor o familiar cercano
DURACIÓN	45 a 60 minutos (puede distribuirse en 2 sesiones)
MATERIALES	Caja pequeña (de zapatos o cartón decorado), papel, marcadores, cola, fotos si la familia puede traerlas, materiales de decoración libres

Objetivo

Crear un objeto de transición concreto que le permita al niño mantener el vínculo simbólico con la persona fallecida a la vez que elabora la permanencia de la pérdida. La caja funciona como un repositorio físico de la memoria afectiva: no niega la muerte, sino que transforma el vínculo roto en algo que puede guardarse, revisitarse y resignificarse a lo largo del desarrollo. Clínicamente, la actividad permite evaluar el estadio de comprensión cognitiva del niño sobre la irreversibilidad de la muerte, identificar idealizaciones o culpas no verbalizadas y rastrear qué aspectos de la persona fallecida el niño logra preservar internamente.

Cómo aplicar

1

Presentación (5 min)

No proponga la actividad en la primera sesión: espere a que haya un espacio de confianza establecido. Muestre la caja vacía y diga algo como: «Estuve pensando en algo. A veces, cuando perdemos a alguien que queremos mucho, nos da miedo olvidarlo. Te quería proponer algo: podemos armar una caja que va a guardar todo lo que quieras recordar de esa persona. Va a ser completamente tuya». No fuerce un entusiasmo artificial. Si el niño duda, normalícelo: «No tiene que ser hoy, la podemos ir armando de a poco».

2

Decoración externa (10 min)

Invite al niño a decorar el exterior de la caja como quiera. Observe la elección de colores, la presencia o ausencia de elementos alegres, cómo la nombra (si es «la caja de papá» o «la caja de la añoranza», eso ya es material clínico). No dirija: acompañe y pregunte, con curiosidad genuina, qué está poniendo.

3

Llenado (15 a 20 min)

Ofrezca hojas en blanco y proponga que el niño escriba, dibuje o recorte cosas para poner dentro: un recuerdo favorito, algo que aprendió de la persona, algo que extraña, algo que le hubiera gustado decir. Si el niño no lee ni escribe, puede dibujar o usted puede ser el escriba. Para los más grandes (7+), proponga también una carta, sin obligación de leerla a nadie.

4

Ritual de cierre (5 min)

Cuando el niño sienta que está listo, propongan cerrar la caja juntos. Pregúntele dónde quiere guardarla en casa. Esto es importante: el lugar que elige (debajo de la cama, en un estante visible, en el cuarto de la mamá) revela mucho sobre el lugar que ocupa el duelo en el cotidiano familiar. La caja puede revisitarse en sesiones futuras, incluso como termómetro de cómo avanza el proceso.

Lectura clínica

Observe con atención qué elige poner el niño y qué deja afuera. La ausencia de ítems relacionados con la persona fallecida —cuando el niño decora la caja pero no logra llenar el interior— puede indicar dificultad de elaboración o evitación defensiva. Cuando pone cosas que «la persona necesitaría» («voy a poner una foto de su equipo para que no se olvide»), eso revela que la comprensión de la permanencia de la muerte todavía se está construyendo: no es patología, es desarrollo normal antes de los 6-7 años. Observe la afectividad durante la actividad: un niño muy acelerado, que llena la caja rápido y sin pausas, puede estar evitando el contacto con el dolor; uno que se detiene, mira el vacío y queda callado probablemente esté elaborando —no interrumpa esos silencios con preguntas inmediatas—. Preste atención a las narrativas de culpa («voy a poner acá el perdón que no pedí», «lo último que le dije fue una pelea»): son puntos que necesitan profundizarse en las sesiones siguientes.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué es lo que más extrañas de esa persona?
- ¿Hay algo que te hubiera gustado decir y no dijiste?
- ¿Qué te parece que esa persona recordaría de vos?
- ¿Hay algún olor, canción o lugar que te la recuerde?
- Cuando sientas que la extrañas, ¿qué hacés con eso?
- ¿Hay algo que aprendiste de ella que va a quedar con vos para siempre?
- Si pudieras guardar un momento dentro de esta caja, ¿cuál sería?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: simplifique el llenado —use solo dibujos y deje que el niño narre mientras dibuja—. Usted registra por escrito debajo de cada dibujo lo que él dice.

Para niños resistentes: no fuerce el llenado. Proponga que la caja quede vacía por ahora y que ponga una cosa por semana. Eso crea un ritual semanal de acceso al duelo sin sobrecargar.

Para niños que perdieron al progenitor en circunstancias traumáticas (muerte violenta, suicidio): evite preguntas sobre el momento de la muerte. Enfóquese en el antes, en los recuerdos anteriores al evento. La elaboración del trauma de la muerte es trabajo de una etapa posterior.

Para niños que niegan la muerte: no confronte directamente. Permita que pongan en la caja lo que quieran. La negación es una protección necesaria; el proceso irá abriendo espacio para la realidad a medida que el vínculo terapéutico sostenga el contacto con el dolor.

TIPO	Actividad proyectiva con dibujo y narrativa
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo por la pérdida de un progenitor, abuelos o persona de referencia
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande (A3 si es posible), marcadores o lápices de colores, lapicera para el terapeuta

Objetivo

Mapear los territorios emocionales del niño en relación con el duelo —qué emociones están presentes, cuáles se están evitando, dónde se siente seguro y dónde siente dolor— mediante un recurso visual espacializado. El «mapa» como metáfora cumple dos funciones: externaliza el mundo interno del niño de forma menos amenazante que la pregunta directa, y crea un documento visual que puede revisitarse en sesiones futuras como termómetro del proceso. La actividad favorece el acceso a contenidos que el niño no logra nombrar verbalmente pero sí ubicar espacialmente —especialmente útil para niños que responden «no sé» a las preguntas emocionales directas—.

Cómo aplicar

1

Presentación (3 min)

Coloque la hoja grande sobre la mesa y diga: «¿Viste alguna vez un mapa? Los mapas muestran lugares. Pero podemos hacer un mapa distinto: un mapa de los sentimientos. Quiero que dibujes un mapa de todo lo que sentís cuando pensás en [nombre]. Puede tener lugares, caminos, colores, lo que quieras. No hay bien ni mal». Si el niño pide ayuda, diga que pueden hacerlo juntos y pregunte: «¿Por dónde empezamos?».

2

Construcción libre (20 a 25 min)

Acompañe al niño mientras dibuja, con preguntas abiertas sobre lo que va construyendo. No interprete en voz alta: solo refleje de vuelta —«Esta zona de acá, ¿qué es?» o «Contame sobre este lugar»—. Observe la distribución espacial: qué está en el centro, qué en los bordes, qué está separado, qué está rodeado de barreras. Si el niño hace solo un dibujo sin estructura de mapa, acéptelo: lo que produzca es el material.

3

Nombramiento (10 min)

Al final, proponga que el niño nombre las regiones del mapa. Puede ofrecer palabras como sugerencia («esto de acá, ¿parece un lugar de alegría o de tristeza?»), pero deje que el niño confirme o corrija. Escriba los nombres en las regiones según él indique. Al cerrar, pregunte: «¿Hay alguna parte del mapa que visitás bastante? ¿Y alguna que evitás?».

4

Guardado del mapa (2 min)

Guarde el mapa en la carpeta del niño en el consultorio. En las sesiones siguientes, proponga revisitarlo: «Mirá el mapa que hicimos. ¿Cambió algo? ¿Hay algún lugar nuevo?». Esto convierte el recurso en un instrumento longitudinal de evaluación del proceso de duelo.

Lectura clínica

La estructura espacial del mapa es, en sí misma, diagnóstica. Los niños que concentran todo el mapa en torno a la persona fallecida —sin espacio para elementos de la vida actual— pueden estar en un duelo que todavía no permite invertir en nuevas relaciones. Los que crean un mapa con muchos lugares alegres y «esconden» la tristeza en un rincón pequeño pueden estar en negación o recibiendo del ambiente familiar el mensaje implícito de que no está permitido sufrir. Atención especial a las «regiones prohibidas» —áreas que el niño delimita pero no quiere nombrar, o que describe como «peligrosas», «oscuras» o «adonde no se puede ir»—: suelen encubrir culpa, enojo con el fallecido o contenidos ligados a las circunstancias de la muerte. No fuerce la entrada: registre y espere a que el proceso cree un espacio seguro. Observe también la presencia o ausencia del niño en su propio mapa: cuando se incluye como personaje o lugar, hay mayor integración del self en el duelo; su ausencia puede indicar disociación del sufrimiento o la sensación de no tener lugar en esa pérdida.

Preguntas orientadoras

- Contame sobre este lugar de acá: ¿qué pasa en él?
- ¿Hay algún lugar del mapa que te guste visitar? ¿Por qué?
- ¿Hay alguno que evites? ¿Qué hay ahí?
- Si la añoranza fuera un lugar del mapa, ¿cómo sería?
- Y el enojo, ¿tendría un lugar en este mapa?
- Mirando el mapa entero, ¿qué sentís?
- Si pudieras cambiar algo del mapa, ¿qué cambiarías?

Adaptaciones

Para niños más pequeños (5-6 años): reemplace la propuesta de «mapa» por «la casa de los sentimientos» —cada ambiente tiene un sentimiento—. Es más concreto y accesible.

Para niños muy verbales y resistentes al dibujo: haga el mapa en forma de lista o descripción oral —usted escribe y el niño dicta los lugares—. Lo importante es la espacialización del contenido.

Para el niño que dice «no sé dibujar»: ofrezca formas geométricas simples —círculos, cuadrados, líneas—. Dígale que el mapa no tiene que ser lindo, solo verdadero.

TIPO	Dinámica terapéutica con metáfora y movimiento
EDAD	4 a 8 años
DEMANDA	Duelo con negación, dificultad para aceptar la permanencia de la muerte
DURACIÓN	30 a 40 minutos
MATERIALES	Globos (no hace falta inflarlos de verdad: pueden representarse con bollos de papel), papelitos, lapicera, hilo

Objetivo

Trabajar concretamente la tensión central del duelo infantil: el niño necesita, a la vez, aceptar que la persona no volverá y mantener el vínculo interno con ella. Este recurso usa la metáfora del globo para externalizar ese proceso: el globo sube, desaparece de la vista, pero el hilo que el niño sostiene representa el recuerdo que permanece. No es un recurso de «cierre» del duelo, sino una forma de mostrar que mantener y dejar ir no son opuestos. Especialmente útil con niños que repiten conductas de espera (se quedan en la ventana esperando el regreso, se niegan a redistribuir las pertenencias, mantienen el lugar en la mesa).

Cómo aplicar

1

Preparación e introducción (5 min)

Siéntese en el piso con el niño. Muestre los materiales y explique: «Hoy vamos a hacer algo distinto. Quiero que pensemos en las cosas que sentimos cuando alguien que queremos se va. Cada cosa que escribamos va a quedar en un papelito chiquito». Si el niño no escribe, usted escribe mientras él habla.

2

Escritura de los contenidos (10 min)

Proponga tres tipos de papeles: (1) cosas que el niño extraña —se escriben y se atan con hilo a un «globo» de papel (un bollo)—; (2) cosas que le recuerdan a la persona —quedan guardadas en el bolsillo o en su mano—; (3) cosas pesadas que el niño carga y que lo cansan —escritas aparte—. No fuerce la separación entre categorías: deje que el niño guíe.

3

La metáfora del globo (10 min)

Tome los «globos» (bollos de papel) con las cosas que pesan. Sostenga el hilo y pídale al niño que suelte el bollo: «se va», pero el hilo queda. Diga: «Mirá, el bollo se fue, pero el hilo sigue acá. Así es con los recuerdos: la persona se fue, pero lo que sentimos no se va con ella». Deje que el niño suelte y sostenga el hilo las veces que quiera. No apure.

4

Lo que queda (5 min)

Pregunte qué quiere hacer el niño con los papeles de los recuerdos —los que quedaron en la mano—. Algunos van a querer llevarlos a casa; otros, ponerlos en la caja de recuerdos (si ya se hizo). Siga al niño.

Lectura clínica

Observe la reticencia del niño a soltar el globo. Si lo sostiene con fuerza y no quiere soltarlo, no fuerce: ese es el material. Diga: «No hace falta soltarlo hoy. Podemos solo sostenerlo un poquito». La resistencia a soltar representa defensas legítimas que necesitan sostén antes del movimiento. Si el niño suelta el globo muy rápido y sin afecto, investigue: puede ser evitación emocional o duelo inhibido. Pregunte: «¿Qué sentiste cuando lo soltaste?». Si la respuesta es un «nada» dicho con liviandad, merece profundizarse. Atención a qué categoría elige para cada cosa: los niños que ponen en «cosas pesadas» afectos como el amor o la añoranza (en lugar del enojo o la culpa) pueden estar señalando que el propio vínculo emocional se vive como una carga, lo que indica investigar el ambiente familiar y los mensajes que el niño recibe sobre cómo comportarse frente a la pérdida.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué sentís cuando pensás en dejar ir el globo?
- ¿Te parece que recordar es distinto de no poder soltar?
- ¿Qué querés guardar con vos para siempre?
- ¿Hay algo que sentís que pesa mucho y que te gustaría poner en el globo?
- Cuando sostenés el hilo, ¿qué estás sosteniendo?
- ¿Te parece que se puede guardar a una persona dentro del corazón sin que esté acá?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 5 años: use la versión literal con un globo real e inflenlo juntos en la sesión. La experiencia sensorial del globo —liviano, que sube— refuerza la metáfora de forma más vívida y accesible al pensamiento concreto.

Para duelo por suicidio o muerte violenta: no use esta actividad en las primeras sesiones. Antes de trabajar el «soltar», el niño necesita haber elaborado mínimamente el trauma de la forma de la muerte. La metáfora del globo funciona cuando hay algún nivel de integración de la realidad de la pérdida, no antes.

Para niños con duelo cronificado (más de 2 años sin movimiento en el proceso): agregue una etapa en la que el niño describa cómo era la vida antes de la pérdida y cómo es ahora. El contraste entre ambos momentos puede abrir la conciencia de que el tiempo pasó y de que es posible moverse.

TIPO	Actividad de expresión escrita y verbal — biblioterapia aplicada
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con culpa, despedidas no hechas, muerte súbita o inesperada
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Papel especial (de color o con bordes decorados), lapiceras de colores, sobre

Objetivo

Crear un espacio de comunicación simbólica con la persona fallecida para que el niño pueda decir lo que quedó sin decir: palabras de amor, pedidos de perdón, preguntas sin respuesta, enojo, añoranza. La carta no necesita leerse a nadie. El acto de escribir tiene función de elaboración independiente de su lectura posterior. Para niños que perdieron al progenitor en una muerte súbita o accidental —sin posibilidad de despedida— esta actividad ofrece lo que el evento real negó: un momento de cierre y de expresión. La carta también sirve para trabajar la culpa infantil: el niño que cree que peleó con el padre «y por eso murió» puede, a través de la carta, visitar y resignificar esa creencia.

Cómo aplicar

1

Creación del contexto (5 min)

Antes de proponer la carta, tenga una conversación breve sobre comunicación y pérdida. Pregunte: «¿Alguna vez te quedaste sin poder decirle algo a alguien que querías mucho?». No dirija hacia la persona fallecida de inmediato: deje que el niño llegue. Si no llega, ofrezca: «A veces, cuando perdemos a alguien, nos quedan cosas adentro que no tuvieron tiempo de salir. Te quería proponer algo: ¿y si escribimos una carta?».

2

Escritura de la carta (20 a 25 min)

Ofrezca el papel especial y aclare que la carta es completamente privada —usted no la va a leer sin permiso—. Proponga que empiece como quiera: por el nombre de la persona, por «hola», por «te quería contar...». Si el niño se traba, ofrezca una estructura de apoyo: (1) Lo que más extraño es...; (2) Algo que me hubiera gustado decirte es...; (3) Quiero que sepas que...; (4) Ahora que te fuiste, yo voy a... No todas: deje que el niño elija por cuál empezar.

3

Lectura y procesamiento (10 min)

Cuando termine, pregunte si quiere compartir alguna parte con usted, sin presión. Si quiere leer, escuche sin interpretar de inmediato. Después de leer, pregunte: «¿Cómo estás ahora? ¿Qué sentiste mientras escribías?». Priorice el procesamiento afectivo antes que cualquier contenido cognitivo.

4

Destino de la carta (5 min)

Pregunte qué quiere hacer con la carta: guardarla en el sobre, ponerla en la caja de recuerdos, llevarla a casa, dejarla en el consultorio. Algunos van a querer «mandarla de verdad»; para eso, puede proponer un ritual: ponerla en el sobre, dirigirla al cielo (o adonde el niño cree que está la persona) y, en sesión, hacer un acto simbólico de entrega. Respete la creencia religiosa de la familia.

Lectura clínica

Atención al tono de la carta. Una carta excesivamente formal y «perfecta» —sin rastro de emoción— puede indicar que el niño todavía no tiene acceso seguro al afecto ligado a la pérdida, o que está escribiendo lo que cree que el terapeuta quiere leer. Aliente la autenticidad: «Puede ser desprolija. Puede ser enojo también. La carta no tiene que ser linda, tiene que ser verdadera». Observe la presencia de culpa explícita o implícita. Cuando el niño escribe «perdón» o «tendría que haber sido mejor», no reestructure cognitivamente de inmediato. Primero acoja: «Venís cargando esto hace tiempo...». La elaboración de la culpa precede a la disputa cognitiva de la creencia. Los niños que escriben cartas llenas de enojo explícito («¿por qué te fuiste?», «me dejaste») están en un proceso sano de reconocimiento del abandono y necesitan que ese enojo sea validado, no silenciado. El enojo con el fallecido es normal y clínicamente importante de acoger.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algo que quisieras mucho haberle dicho a esa persona?
- Si pudieras hablar con ella cinco minutos ahora, ¿qué le dirías?
- ¿Hay algo que quedó inconcluso entre ustedes dos?
- ¿Sentís que ella sabía cuánto la querías?
- ¿Hay algo que sientas que necesita un perdón, de tu parte o de la de ella?
- ¿Qué te parece que ella te diría si pudiera responder esta carta?

Adaptaciones

Para niños que no escriben: reemplace la carta por una grabación de audio. El niño le habla al celular (o grabador) como si estuviera llamando a la persona. El audio puede guardarse o borrarse: la elección es suya.

Para niños que rechazan la actividad: no fuerce. Proponga que escriban la carta de un personaje ficticio que perdió a alguien. La distancia del personaje puede ser el espacio seguro que necesitan para acceder al contenido.

Para duelo por suicidio: la actividad es especialmente potente pero exige cautela. El niño puede cargar una culpa devastadora («si hubiera hecho algo distinto...»). Asegúrese de que haya sostén terapéutico establecido antes de proponerla y esté preparado para una sesión de gran intensidad afectiva.

TIPO	Actividad de reconstrucción narrativa e integración de recuerdos
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con idealizaciones extremas o con enojo y ambivalencia hacia la persona fallecida
DURACIÓN	50 a 60 minutos (puede dividirse en 2 sesiones)
MATERIALES	Hojas pegadas en secuencia (formando una tira larga) o papel kraft, marcadores, cola, fotos opcionales

Objetivo

Construir una narrativa integrada de la relación con la persona fallecida —que incluya tanto momentos alegres como momentos de conflicto, distancia o dolor— para que el niño pueda elaborar el duelo desde una representación más realista y humanizada. La idealización excesiva de la persona muerta es un fenómeno común y comprensible, pero clínicamente puede dificultar el duelo al crear una imagen irreal que el niño no logra integrar. Del mismo modo, los niños con relaciones ambivalentes (padre ausente, madre que peleaba mucho) suelen cargar culpa y confusión porque sienten que no deberían enojarse con alguien que murió. La línea de tiempo ofrece un soporte concreto para contener la ambivalencia: lo bueno y lo difícil pueden coexistir en el mismo papel.

Cómo aplicar

1

Armado físico (5 min)

Pegue las hojas formando una tira horizontal larga (al menos 60 cm). Colóquela frente al niño. Explique: «Vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Sabés qué es? Es como un camino que muestra todo lo que pasó, del principio hasta ahora. Vamos a hacer la línea de tiempo de tu vida con [nombre]». Marque a la izquierda el nacimiento del niño y a la derecha el momento actual.

2

Llenado (25 a 30 min)

Pida que el niño vaya colocando momentos a lo largo de la línea, del pasado al presente. No dirija hacia lo positivo o lo negativo: acepte lo que venga. Para cada momento, pregunte qué estaba sintiendo. Observe si logra colocar momentos de conflicto, distancia o dolor, o si produce solo una línea idealizada. Si solo aparecen momentos positivos, no confronte: pregunte con cuidado: «¿Había algún momento que era más difícil? Toda relación los tiene, ¿no?».

3

El punto de la pérdida (5 min)

Cuando lleguen al momento de la muerte, no lo saltee. Márquelo en la línea junto al niño. Pregunte: «¿Cómo fue ese día para vos?» y «¿Qué cambió después de ese momento?». El niño puede continuar la línea más allá de la muerte —cómo fue la vida después— o querer parar ahí. Respete el momento de detención.

Lectura de la línea (5 min)

Miren juntos la línea entera. Pregunte: «Mirando todo esto, ¿qué notás?» y «¿Qué parte no querés olvidar nunca?». Guarde la línea en el consultorio: puede retomarse en sesiones futuras como documento vivo del proceso.

Lectura clínica

Observe la densidad de la línea. Los niños que producen líneas muy escasas, con pocos eventos, pueden tener una memoria afectiva empobrecida de la relación (ausencia física del fallecido, relación distante) o estar en un proceso de borramiento defensivo. Investigue cuál de las dos hipótesis se ajusta mejor a la historia contada por la familia. Las líneas con «saltos» —períodos que el niño saltea sin nombrar— merecen atención: esos silencios suelen corresponder a períodos de conflicto familiar, enfermedad, separación de los padres u otros eventos que el niño no sabe cómo insertar en la narrativa del duelo. No fuerce el nombramiento: registre para profundizar después. Cuando el niño pone un solo punto en la línea (el momento de la muerte) y no logra construir nada antes ni después, eso señala que el trauma de la muerte está sobreponiéndose a la totalidad de la relación: la muerte tomó el lugar de la vida que hubo antes. Es un signo importante de duelo complicado que requiere atención.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuál es el momento que más te gusta recordar?
- ¿Había algún momento que era más difícil entre ustedes dos?
- Si pudieras ponerle un olor, una música o un color a ese momento de la línea, ¿qué sería?
- ¿Hay algún período de la línea que preferirías que no hubiera pasado?
- Mirando la línea entera, ¿cómo describirías a esa persona para alguien que nunca la conoció?
- ¿Qué te parece que era lo que esa persona más quería de vos?

Adaptaciones

Para niños que perdieron al progenitor muy temprano (antes de los 3 años): adapte la actividad para incluir también historias contadas por la familia. El niño puede poner en la línea «cosas que me contaron» y «cosas que yo recuerdo», una distinción importante para que comprenda cómo construye la imagen de la persona.

Para relaciones de abandono previo a la muerte (padre que se fue de casa y después falleció): incluya en la línea tanto el período de convivencia como el de ausencia. No trate la ausencia como algo neutro: pregunte qué sentía el niño durante ese tiempo.

Para niños muy pequeños que no logran construir la línea solos: usted puede iniciar colocando hitos que la familia relató, y el niño va confirmando, corrigiendo o agregando lo que sabe.

TIPO	Juego de cartas con categorización emocional
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo con dificultad de nombramiento emocional, duelo inhibido, niño que responde «estoy bien» a todo
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Cartas con nombres de emociones (una por carta: añoranza, enojo, miedo, alivio, culpa, amor, confusión, celos, soledad, vergüenza, tristeza, alegría, ansiedad, paz), tres cajitas o zonas en la mesa: «siento esto», «nunca siento esto», «a veces siento esto»

Objetivo

Ampliar el vocabulario emocional del niño en relación con el duelo, rompiendo la barrera del «estoy bien» o del «no sé» que suele bloquear el acceso al proceso terapéutico. Muchos niños en duelo no tienen dificultad para sentir, sino para nombrar. Otros reciben mensajes implícitos del ambiente de que ciertas emociones están prohibidas respecto de la persona muerta (especialmente el enojo y el alivio). El formato de juego con cartas quita el peso de la pregunta directa y permite que el niño acceda a contenidos que no accedería por preguntas abiertas. Incluir emociones «socialmente prohibidas» en el duelo —como el alivio (sobre todo cuando había conflicto o enfermedad prolongada) y los celos— es clínicamente fundamental.

Cómo aplicar

1

Armado del juego (3 min)

Organice las tres zonas en la mesa: «Siento esto», «A veces siento», «Nunca siento» —con hojas de color o cajitas—. Mezcle las cartas de emoción. Explique: «Vamos a jugar. Yo te voy a dar una carta por vez con el nombre de un sentimiento. Vos la vas a poner en uno de los tres lugares, pensando en cómo te estás sintiendo desde que [nombre] se fue. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Podés decir lo que quieras».

2

Distribución de las cartas (15 a 20 min)

Entregue una carta por vez. Para cada carta que el niño ponga en «siento esto» o «a veces siento», haga una pregunta breve de profundización: «Contame un momento en que sentiste esto». No lo haga con todas: elija las que parecen más cargadas afectivamente. Para las de «nunca siento», acoja sin confrontar, pero registre mentalmente: a veces lo que el niño rechaza más rápido es lo que más lo activa.

3

La carta sorpresa (5 min)

Al final, agregue una última carta en blanco y diga: «Esta carta está vacía. Si pudieras escribir el nombre de un sentimiento que no apareció en ninguna otra, ¿cuál pondrías?». Suele ser la emoción más significativa de la sesión.

Visión general (5 min)

Miren juntos las cartas distribuidas. Pregunte: «De todo lo que quedó en el grupo “siento esto”, ¿cuál es la más pesada?» y «¿Cuál preferirías no sentir?». Esto crea una jerarquía clínica para las próximas sesiones.

Lectura clínica

Atención especial a las cartas de «alivio» y «enojo». Cuando el niño las pone rápido en «nunca siento» o se ríe nervioso al leerlas, puede indicar que recibió un mensaje —explícito o implícito— de que esas emociones están prohibidas respecto de la persona muerta. El alivio es especialmente común y silenciado en familias donde hubo enfermedad prolongada, conflicto conyugal intenso o una figura parental abusiva. Cuando el niño pone «culpa» en «siento esto» sin pausar ni mostrar afecto, puede estar tan habituado a cargar esa culpa que se volvió parte de su identidad; es distinto de cuando pone «culpa», se detiene, mira la carta y queda callado —en ese segundo caso hay algo vivo que merece profundización inmediata—. Observe también la dinámica corporal: los niños que aceleran y distribuyen las cartas sin parar pueden estar evitando el contacto real con el contenido. En ese caso, proponga desacelerar: «Esperá un poco en esta. Contame más de ella».

Preguntas orientadoras

- ¿Sabías que se podía sentir esto cuando alguien muere? ¿Alguien te dijo que estaba permitido?
- ¿Cuál de estas cartas fue la más difícil de ubicar en algún lugar?
- ¿Hay algún sentimiento que te parece que no deberías sentir, pero lo sentís?
- ¿Hay alguien con quien hablás de estas cosas que estás sintiendo?
- Cuando sentís [emoción elegida], ¿qué hacés con eso?
- Si [nombre] viera estas cartas, ¿qué te parece que diría?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: reemplace los nombres escritos por caritas que expresen cada emoción (impresas o dibujadas). El formato pictórico es más accesible para prelectores.

Para niños muy intelectualizados que categorizan todo rápido: agregue una ronda en la que deban hacer un gesto o sonido que represente cada emoción antes de ubicarla. El componente corporal rompe la defensa cognitiva.

Para uso con la familia (progenitor sobreviviente presente): puede hacer el juego por separado con el niño y con el adulto, y después comparar los resultados juntos; eso favorece la comunicación sobre el duelo dentro de la familia.

TIPO	Proyecto terapéutico de larga duración — construcción de un libro artesanal
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo por muerte súbita, duelo con riesgo de borramiento de la memoria del fallecido, niño que perdió al progenitor muy temprano
DURACIÓN	Proyecto de varias sesiones (4 a 8 encuentros de 30 a 40 min cada uno)
MATERIALES	Cuaderno u hojas abrochadas formando un librito, fotos (las trae la familia), materiales de decoración, marcadores, cola

Objetivo

Construir, a lo largo de varias sesiones, un libro de vida sobre la persona fallecida —escrito e ilustrado por el niño— que cumpla tres funciones clínicas a la vez: (1) preservar la memoria de forma concreta y accesible; (2) darle al niño un rol activo en el duelo —no es pasivo ante la pérdida, es el narrador—; (3) integrar la información sobre la persona que el niño recibió de terceros con la que vivió directamente. Este recurso está especialmente indicado cuando hay riesgo de borramiento de la figura del fallecido por parte del ambiente familiar: familias que no hablan del muerto, que retiran las fotos de la casa, que intentan «seguir adelante» sin espacio para el duelo.

Cómo aplicar

1

Sesión 1 — Presentación y estructura del libro (30 min)

Presente el proyecto como algo especial: «Te quiero proponer algo que va a llevar algunas sesiones. Vamos a hacer un libro sobre [nombre]. Un libro de verdad, escrito y dibujado por vos». Arme la estructura del librito junto al niño: decidan cuántas páginas, el título, la tapa. La tapa ya es material clínico: ¿cómo quiere el niño presentar a esa persona al mundo?

2

Sesiones 2 a 6 — Páginas temáticas

Cada sesión trabaja una sección del libro. Sugerencias: (1) «Quién era [nombre]»: descripción física y de personalidad; (2) «Las cosas que hacíamos juntos»: recuerdos de actividades compartidas; (3) «Lo que aprendí de él/ella»: legado afectivo y práctico; (4) «Algo difícil que recuerdo»: espacio para la ambivalencia y los recuerdos de conflicto; (5) «Lo que siento cuando lo/la recuerdo»: página de expresión emocional libre; (6) «Lo que quiero que la gente sepa de él/ella»: cómo quiere el niño que sea recordado.

3

Última sesión — Cierre y ritual (30 min)

Lean el libro juntos de principio a fin. Pregunte al niño si quiere agregar algo. Proponga un ritual de cierre: firmar como autor, poner una dedicatoria. Conversen dónde va a quedar el libro —en casa o en el consultorio—. Muchos niños piden llevarlo a casa y mostrárselo al familiar sobreviviente: puede ser un momento terapéutico importante para la familia.

Lectura clínica

Observe cómo decide el niño organizar el contenido de cada página. La sección «algo difícil que recuerdo» suele ser la más reveladora, y la que más se resiste a llenar. La resistencia a incluir cualquier aspecto negativo o difícil del fallecido es un indicador de idealización protectora. En ese caso no confronte: diga «toda relación tiene momentos más difíciles, es parte de ser humano» y deje la elección al niño. El libro funciona también como termómetro del apoyo familiar: los niños cuyas familias hablan abiertamente del fallecido llegan a las sesiones con más historias y más detalles; los de familias silenciosas llegan con páginas en blanco, lo que indica necesidad de trabajo paralelo con el progenitor sobreviviente. La sección «lo que quiero que la gente sepa» es particularmente importante para niños que sienten que el fallecido fue borrado o mal comprendido por la familia o el entorno social: ese espacio de autoría le devuelve al niño el poder de definir la narrativa sobre quién fue.

Preguntas orientadoras

- Si alguien que nunca conoció a [nombre] leyera este libro, ¿qué te gustaría que sintiera?
- ¿Hay alguna historia que no podés poner acá porque no te alcanzan las palabras?
- ¿Qué página fue la más difícil de hacer? ¿Por qué?
- ¿Hay alguien a quien te gustaría que leyera este libro?
- Haciendo este libro, ¿descubriste algo que no sabías antes?

Adaptaciones

Para niños que perdieron al progenitor antes de los 3 años (memoria muy limitada): incluya una sesión en la que invite a un familiar a participar y contar historias que el niño no vivió directamente. El niño ilustra mientras el adulto narra: cocreación intergeneracional del libro.

Para niños muy resistentes al trabajo formal de duelo: mantenga el formato de libro pero cambie la propuesta —en lugar de un libro sobre el fallecido, «un libro sobre mí y [nombre]»—. La centralidad del niño en la narrativa reduce la amenaza del contacto con la pérdida.

TIPO	Instrumento de monitoreo clínico con formato lúdico
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Uso longitudinal a lo largo del acompañamiento — aplicar al inicio, a la mitad y al final del proceso
DURACIÓN	15 a 20 minutos por aplicación
MATERIALES	Hoja con un termómetro dibujado (escala de 0 a 10 con zonas de color), preparada antes de la sesión

Objetivo

Ofrecer al niño un instrumento visual y concreto de automonitoreo del proceso de duelo, que a la vez funciona como herramienta de evaluación clínica longitudinal para el terapeuta. El termómetro externaliza un proceso que es, por naturaleza, interno y difuso, permitiendo que el niño desarrolle metacognición sobre sus propios estados afectivos. Al aplicarse repetidamente a lo largo del acompañamiento, genera un registro del movimiento (o el estancamiento) del proceso. Clínicamente, es también un instrumento de comunicación con la familia: los resultados pueden compartirse con el progenitor sobreviviente para facilitar la conversación sobre el duelo en casa.

Cómo aplicar

1

Preparación de la hoja (antes de la sesión)

Dibuje o imprima un termómetro grande con escala de 0 a 10. Defina las zonas con colores: 0 a 3 = azul oscuro («el dolor está muy presente»); 4 a 6 = amarillo («hay días buenos y días difíciles»); 7 a 10 = verde («me estoy sintiendo más liviano»). Deje espacio para que el niño escriba o dibuje al lado de cada zona.

2

Aplicación con el niño (15 min)

Explique: «Este es un termómetro, pero no es para medir la fiebre. Es para medir cómo te estás sintiendo por dentro, en relación con la añoranza y el dolor de no tener más a [nombre]. El 0 sería si el dolor fuera muy fuerte, tan fuerte que cuesta hacer cualquier cosa. El 10 sería si sintieras que estás bien, que el dolor dio un espacio. ¿Dónde estás hoy?». Después de que marque el número, explore: «¿Por qué elegiste ese número y no uno mayor (o menor)?» y «¿Qué tendría que pasar para subir un número?». Al reaplicarlo en sesiones futuras, compare los resultados frente al niño: «Mirá, la sesión pasada estabas en el 4. Hoy marcaste 6. ¿Qué cambió?». Ese movimiento de comparación es clínicamente poderoso: el niño ve concretamente que el proceso se está moviendo.

Lectura clínica

Cuando el niño marca números muy altos (8, 9, 10) en las primeras sesiones tras la pérdida, puede indicar negación o anestesia emocional, no recuperación. Pregunte: «¿Cómo te sentís cuando pensás en él/ella ahora?». Si el afecto no se corresponde con el número alto, el termómetro se está usando de forma defensiva. Cuando los números quedan estancados durante muchas semanas —siempre el mismo—, es señal de duelo complicado o de un ambiente que no permite el movimiento. Investigue el contexto familiar: ¿se habla de la añoranza en casa?, ¿el progenitor sobreviviente está disponible emocionalmente? Cuando el niño se niega a marcar cualquier número —dice «no sé» o lo deja en blanco—, eso no es una falla de la actividad: es dato clínico. Significa que todavía no tiene acceso suficiente a sus estados internos para diferenciarlos en una escala. En ese caso, trabaje primero los recursos de nombramiento emocional (como el Tribunal de las Emociones) antes de volver al termómetro.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué ese número y no uno más o uno menos?
- ¿Cómo estuvo la semana en relación con ese número?
- ¿Qué pasó que te hizo subir (o bajar) respecto de la última vez?
- ¿Qué te parece que tendría que pasar para sentirte un número más liviano?
- ¿Hay algún momento de la semana en que el número es distinto, más pesado o más liviano?

Adaptaciones

Para niños a los que no les gustan los números: reemplace la escala numérica por tamaños de nube —nube pequeña (dolor leve), nube mediana, nube de tormenta (dolor muy intenso)—. La metáfora de la nube que pasa es en sí misma terapéutica.

Para uso en una sesión de devolución con la familia: presente el termómetro como un gráfico de cómo se fue sintiendo el niño a lo largo de las sesiones (con su autorización). Esto facilita la conversación entre el progenitor y el niño sobre el proceso en casa.

TIPO	Juego guiado con narrativa y miniaturas
EDAD	4 a 8 años
DEMANDA	Duelo reciente, niño con dificultad para comprender la permanencia de la muerte, reorganización familiar tras la pérdida
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Miniaturas de caja de arena (familia, casa, personajes), bandeja de arena si está disponible; alternativa: hoja grande dividida en dos campos y miniaturas sobre ella

Objetivo

Trabajar la reorganización simbólica de la estructura familiar tras la pérdida, usando el juego como lenguaje primario de elaboración. La división entre «antes» y «después» no busca oponer los dos momentos, sino que el niño pueda reconocer que la familia cambió, y que ese cambio puede nombrarse, representarse y, eventualmente, integrarse. El uso de miniaturas da una distancia simbólica segura: el niño puede mover a la «familia de juguete» sin tener que hablar directamente de la propia. Esto es especialmente importante para niños que se disocian de su propio duelo cuando se los interroga de forma directa.

Cómo aplicar

1

Armado del campo (5 min)

Divida la mesa (o bandeja de arena) en dos campos: «Antes» y «Después». Si no hay bandeja, use una hoja grande A2 dividida por una línea. Ponga a disposición las miniaturas. Explique: «Vamos a jugar con este campo. Acá es el antes —cómo era antes—. Acá es el después —cómo es ahora—. Vos elegís qué va en cada lugar».

2

Campo del «Antes» (15 min)

Pida que el niño arme el campo del antes, usando las miniaturas para representar la familia, la casa, las cosas que existían. No dirija. Observe quién es colocado dónde, las cercanías y distancias entre las figuras, qué se excluye. Haga preguntas abiertas: «¿Quién es este? ¿Dónde queda?». Registre mentalmente la configuración.

3

Campo del «Después» (15 min)

Ahora pida que arme el campo del después, con cómo están las cosas ahora. Observe los cambios respecto del antes: quién salió, quién quedó, quién cambió de lugar. La persona fallecida puede aparecer de formas inesperadas en el después: como miniatura todavía presente, como una ausencia marcada por un espacio vacío, o como un elemento que el niño busca pero no encuentra entre las miniaturas. Todo eso es material clínico.

Comparación y narrativa (10 min)

Muestre los dos campos lado a lado y pregunte: «¿Qué cambió?». Deje que el niño compare. Pregunte: «¿Cómo te sentís mirando el después?» y «¿Hay algo del antes que te gustaría traer al después?». Si el niño quiere reorganizar el campo del después de otra forma, déjelo. La reorganización simbólica es, en sí misma, el acto terapéutico.

Lectura clínica

Observe la posición de la persona fallecida en el campo del «después». Los niños que todavía la colocan ahí («sigue acá porque está en el cielo») están elaborando la permanencia de la muerte de forma consistente con el desarrollo —para menores de 7 años, es esperable—. En niños más grandes, esa representación puede indicar que la comprensión de la irreversibilidad aún está incompleta o que la familia sostiene una narrativa que dificulta la elaboración. Observe cómo se representa el niño a sí mismo en ambos campos: cuando pone su propia miniatura muy periférica, aislada o ausente en el después, señala una experiencia de marginación en el duelo familiar —el niño que siente que el duelo de los adultos excluyó al suyo—. La presencia de nuevos elementos en el después que no estaban en el antes (nueva pareja del progenitor sobreviviente, casa nueva, nuevos hermanos) es material clínico rico sobre cómo procesa el niño los múltiples cambios simultáneos que suelen acompañar la muerte de un progenitor.

Preguntas orientadoras

- ¿Quién es cada uno acá en el campo? Presentame a la familia.
- ¿Qué cambió de un campo al otro?
- ¿Hay alguien que estaba en el antes y extrañaste en el después?
- ¿Cómo te sentís mirando el campo del después?
- Si pudieras cambiar algo del campo del después, ¿qué cambiarías?
- ¿Hay algún lugar donde [nombre] todavía está presente en el campo del después?

Adaptaciones

Para niños sin acceso a miniaturas (contextos con pocos recursos): reemplace por dibujo. Divida la hoja en dos campos y el niño dibuja las dos escenas. El principio y la lectura clínica son los mismos.

Para niños en una reorganización familiar compleja (nueva pareja, mudanza, escuela nueva): agregue un tercer campo —«lo que imagino para el futuro»— creando una tríada temporal que trabaja la proyección y la esperanza además de la elaboración de la pérdida.

Para niños con buena conciencia de la muerte: puede nombrar explícitamente que el campo del después es «cómo es la familia sin [nombre]», sin metáforas. Con comprensión cognitiva más avanzada, el nombramiento directo es más respetuoso que la protección simbólica excesiva.

TIPO	Actividad de dibujo proyectivo con narrativa guiada
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Fase de resignificación del duelo — cuando el niño ya tiene alguna elaboración y necesita trabajar la continuidad del vínculo con el fallecido
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja A4 con una silueta humana dibujada (que representa al niño), marcadores de colores

Objetivo

Trabajar la cuarta tarea del duelo propuesta por Worden —encontrar una forma de mantener la conexión con la persona fallecida mientras se embarca en una nueva fase de vida— de manera concreta, visual y accesible. La actividad parte del principio de que el duelo sano no exige abandonar el vínculo con el muerto, sino transformarlo: de una relación de presencia física a una de presencia interna. La silueta del niño llena con elementos de la persona fallecida es una externalización poderosa de ese proceso interno. Está indicada para niños que ya atravesaron la aceptación de la permanencia de la muerte y están en la fase en que el duelo empieza a ceder espacio para la reinversión en la vida, y que a veces sienten culpa por eso.

Cómo aplicar

1

Presentación (5 min)

Entregue la hoja con la silueta y explique: «Esta silueta sos vos. Te quiero proponer algo: sabemos que [nombre] se fue. Pero algunas cosas que él/ella tenía quedan dentro nuestro, las llevamos sin darnos cuenta. Quiero que pienses y dibujes, dentro de la silueta, todo lo que quedó de [nombre] dentro tuyo». Dé ejemplos concretos si hace falta: «puede ser algo que enseñaba, una forma de ser, una palabra que siempre escuchabas, un olor que recordás...».

2

Llenado (20 a 25 min)

El niño llena la silueta con palabras, dibujos, colores o símbolos que representen lo que «quedó» del fallecido dentro suyo. No dirija. Acompañe con interés genuino. Pregunte por cada elemento que agrega: «Contame de esto». La ubicación dentro de la silueta también es significativa: qué queda en el corazón, qué en la cabeza, qué en las manos.

3

Fuera de la silueta (5 min)

Cuando el niño termine el interior, proponga que también ponga afuera las cosas del fallecido que no quiere cargar —no como rechazo, sino como distinción de lo que es suyo y lo que era del otro—. Esa diferenciación es clínicamente importante: los niños en duelo a veces internalizan no solo los aspectos positivos, sino también los patrones problemáticos del fallecido.

4

Narrativa y cierre (10 min)

Pida que el niño «lea» lo que hay dentro de la silueta. Escuche con atención qué eligió cargar. Cierre con: «Todo esto que está dentro de la silueta es parte de vos ahora, y también es una forma de que [nombre] siga presente». Si surge la emoción, sostenga el silencio.

Lectura clínica

Observe la proporción entre lo que hay dentro y lo que hay fuera de la silueta. Un niño que pone todo dentro —sin nada afuera— puede estar en un proceso de fusión con el fallecido que dificulta la individuación. Pregunte: «¿Hay algo que era solo de él/ella y que no hace falta que sea tuyo?». Una silueta vacía —un niño que no logra identificar nada que haya quedado del fallecido dentro suyo— puede indicar empobrecimiento del vínculo antes de la muerte (relación distante o ausente) o bloqueo de acceso a la memoria afectiva. No interprete directamente: pregunte «¿Hay algo que hacés hoy y que tiene alguna relación con [nombre]?». A veces el legado está en las acciones, no en los recuerdos conscientes. La presencia de elementos negativos dentro de la silueta («su enojo», «cómo gritaba») es muy relevante: no la minimice. Pregunte: «¿Querés cargar esto o querés ponerlo afuera?». Eso le da al niño agencia sobre lo que internaliza, y esa agencia es parte de la elaboración sana del duelo.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algo que hacés hoy que aprendiste de él/ella?
- ¿Hay algo que, cuando lo hacés, te hace pensar en él/ella?
- ¿Te parece que cargás algo de su forma de ser?
- ¿Hay algo que no querés cargar, algo que era muy de él/ella pero que no hace falta que sea tuyo?
- Mirando lo que hay dentro de la silueta, ¿cómo te sentís?
- ¿Te parece que se puede estar bien y aun así cargar la añoranza?
- ¿Qué te parece que a él/ella le hubiera gustado dejarte?

Adaptaciones

Para niños que perdieron al progenitor muy temprano (antes de los 3 años): trabaje el legado a partir de lo que cuenta la familia —«¿qué dicen las personas que heredaste de él/ella?»—. El recurso se transforma en una actividad de construcción de identidad narrativa basada en las historias de otros.

Para niños con culpa por sentirse bien: la frase de cierre es especialmente importante. Normalice explícitamente: «Sentirte bien no significa que estés olvidando. Podés estar feliz y a la vez querer y extrañar. Las dos cosas pueden existir juntas».

Para niños que inician una nueva etapa de vida (escuela, hogar o configuración familiar nueva): incluya una segunda silueta que represente el futuro —«¿qué querés llevar de este legado a esta nueva etapa?»—. La actividad se vuelve un puente entre el duelo y la reinversión en la vida.

TIPO	Técnica de dramatización y diálogo simbólico
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con cosas no dichas, relación ambivalente, enojo no expresado, culpa intensa
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Dos sillas, una frente a la otra

Objetivo

Ofrecer al niño un espacio de comunicación simbólica directa con la persona fallecida mediante una técnica adaptada de la silla vacía gestáltica, calibrada para el lenguaje y el desarrollo infantil. Está especialmente indicada cuando hay contenidos no verbalizados que bloquean la elaboración: enojo con el fallecido por haberse ido, pedidos de perdón por peleas antiguas, preguntas sobre la muerte que nadie responde, o simplemente cosas que el niño quería haber dicho. A diferencia de la carta escrita, esta técnica trabaja con la presencia y la espontaneidad, con un impacto afectivo más inmediato y directo. Exige un vínculo terapéutico bien establecido antes de proponerla.

Cómo aplicar

1

Preparación del setting (5 min)

Ubique dos sillas una frente a la otra. Siéntese al lado del niño, no directamente entre él y la silla vacía. Explique con calma: «Esta silla va a representar a [nombre]. Podés decirle todo lo que quieras: lo que querías decir, preguntar, lo que quedó sin palabras. No tiene que ser lindo. Puede ser cualquier cosa». Si el niño duda, díglele que puede empezar con usted a su lado.

2

Inicio del habla (10 a 15 min)

Invite al niño a sentarse frente a la silla vacía y a empezar. Si se traba, ofrezca una entrada: «Podés empezar diciendo su nombre, podés decir hola». Muchos niños empiezan con cosas simples y, en medio del habla, acceden a contenidos mucho más densos. Permanezca presente y en silencio, sosteniendo el espacio. Intervenga solo si el niño se angustia mucho sin poder continuar.

3

Inversión opcional (10 min)

Para niños con buena capacidad de simbolización, a partir de los 8 años, proponga la inversión: «¿Y si te sentás en la silla de [nombre] y me decís lo que te parece que él/ella te respondería?». No es obligatorio y no debe forzarse. Cuando el niño logra hacerlo, el resultado es muy rico: proyecta en la voz del fallecido aquello que él mismo necesita escuchar.

4

Procesamiento (10 min)

Después de la dramatización, retome la conversación directa: «¿Cómo estás ahora?» y «¿Había algo que no esperabas que saliera?». No interprete de inmediato. Acoja el estado afectivo antes de cualquier elaboración cognitiva.

Lectura clínica

Observe lo que el niño no logra decir. Los silencios largos y las pausas son tan informativos como el contenido hablado. Un niño que se sienta y queda en silencio prolongado está, probablemente, en contacto con algo muy intenso que todavía no tiene forma verbal. No llene ese silencio. Un niño que habla con mucha fluidez pero sin afecto aparente puede estar describiendo sin contacto real con el contenido emocional; desacelere: «Esperá. Acabás de decir algo muy importante. Quedate un poco con eso». La inversión de silla es clínicamente reveladora: lo que el niño pone en boca del fallecido suele ser lo que él más necesita escuchar —perdón, permiso para ser feliz, reconocimiento del amor—. Si el fallecido dice cosas punitivas o críticas, indica que la representación interna del fallecido carga aspectos agresivos que hay que trabajar.

Preguntas orientadoras

- Si pudieras hacerle una pregunta ahora, ¿cuál sería?
- ¿Hay algo que necesitás que él/ella sepa?
- ¿Qué te parece que te diría si pudiera responder?
- ¿Hay algo que quedó entre ustedes dos y que todavía pesa?
- ¿Qué sentiste al decir esto en voz alta?
- ¿Había algo que querías decir hace mucho y nunca pudiste?

Adaptaciones

Para niños de 5 a 7 años: en lugar de la silla vacía, use un muñeco o peluche que represente al fallecido. El objeto concreto reduce la abstracción de la propuesta.

Para niños muy resistentes: no insista con este formato. Proponga que escriban o dibujen lo que dirían. La resistencia al formato oral puede ser una defensa legítima.

Para duelo por suicidio: técnica especialmente potente y delicada. El niño puede expresar enojo intenso, culpa y preguntas sin respuesta sobre el porqué. No intente responder el «porqué»: acoja la pregunta como el dolor que es.

TIPO	Recurso de uso continuo entre sesiones — diario terapéutico
EDAD	7 a 10 años con lectura y escritura establecidas
DEMANDA	Duelo en fase activa, niño que necesita apoyo entre sesiones y un canal de expresión cotidiano
DURACIÓN	Presentación en sesión: 20 min. Uso autónomo entre sesiones.
MATERIALES	Cuaderno pequeño, lapicera o lápices de colores

Objetivo

Crear un canal de expresión emocional estructurado que el niño pueda usar de forma autónoma entre las sesiones, reduciendo el aislamiento del duelo en el cotidiano y ofreciendo al terapeuta material rico para explorar. El diario cumple función de contención: cuando el niño está solo y llega la añoranza, tener un lugar definido para ponerla evita que el afecto desborde sin canal de salida. Para niños en duelo reciente, sobre todo en los primeros meses, la semana entre sesiones puede ser muy larga; el diario acorta ese espacio al crear un ritual diario de cuidado del propio estado emocional. Importante: el diario no es una tarea. Nunca lo reclame ni evalúe su llenado.

Cómo aplicar

1

Sesión de presentación — Creación del diario (20 min)

Presente el cuaderno: «Este diario es solo tuyo. Podés escribir, dibujar, pegar cosas, dejar en blanco los días que no quieras escribir. No hay reglas». Proponga que el niño decore la tapa en la sesión, creando vínculo con el objeto. Muestre tres tipos de página posibles: (1) Página del día: cómo fue el día en relación con el duelo, una palabra, un color, una frase; (2) Página de recuerdo: cuando recuerde algo del fallecido; (3) Página de lo que necesitaba decir: para cuando surja algo que no logra decir en voz alta. Deje que el niño elija qué tipos usar.

2

En las sesiones siguientes (10 a 15 min al inicio)

Empiece cada sesión preguntando: «¿Escribiste en el diario esta semana? ¿Hay algo que quieras mostrarme o contarme?». Si no escribió, acoja sin juzgar. Si escribió y no quiere mostrarlo, respételo. El diario es suyo. Lo que comparte es una elección activa de confianza.

Lectura clínica

La regularidad del llenado es dato clínico. Un niño que llena todos los días busca activamente un canal de expresión. Uno que nunca lo llena puede estar en evitación o simplemente no tener el hábito. Cuando el niño deja de escribir tras un período regular, investigue: puede ser señal de mejoría y menor necesidad del canal, o señal de duelo inhibido o de silenciamiento en el ambiente familiar. Lo que trae del diario a la sesión suele ser lo más activado en la semana, con frecuencia el punto más sensible del proceso. Trate el contenido traído del diario con prioridad.

Preguntas orientadoras

- ¿Escribiste algo esta semana que quieras contarme?
- ¿Hubo algún día más difícil? ¿Qué escribiste ese día?
- ¿Hay alguna página que no quieras mostrarme pero puedas decirme de qué se trata?
- ¿Cómo te sentís después de escribir?
- ¿Hubo algo que quisiste escribir pero no encontraste las palabras?

Adaptaciones

Para niños que todavía no escriben: «diario de dibujos», cada día un dibujo o un círculo con el color que representa cómo se está sintiendo.

Para niños resistentes a cualquier registro: «diario de voz» grabado en el celular de los padres.

Para niños en un ambiente doméstico inseguro: guarde el diario en el consultorio para proteger la privacidad del niño.

TIPO	Construcción de un ritual terapéutico de uso doméstico con orientación a la familia
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	Duelo con síntomas nocturnos: dificultad para dormir, pesadillas, miedo a la oscuridad, hiperapego a la figura cuidadora
DURACIÓN	30 a 40 minutos en sesión para la construcción; práctica diaria en casa
MATERIALES	Papel para dibujar el ritual, objeto de transición elegido por el niño

Objetivo

Construir junto al niño un ritual nocturno personalizado que funcione como ancla de regulación emocional en el momento del día en que el duelo suele ser más intenso. La noche es un período crítico para los niños en duelo: la ausencia de estímulos externos, el silencio y la separación del cuidador para dormir reactivan la experiencia de pérdida de forma aguda. Los niños que perdieron a un progenitor suelen presentar dificultad para dormir, pesadillas recurrentes, rechazo a ir al cuarto solos y conductas regresivas. El ritual nocturno no elimina el sufrimiento, pero ofrece previsibilidad, contención y la sensación de que hay una forma de atravesar el momento difícil. El diferencial clínico es que el ritual lo construye el propio niño en sesión, lo que aumenta mucho la adhesión.

Cómo aplicar

1

Mapeo de las noches (10 min)

Investigue cómo son las noches del niño: «¿Cómo estás durmiendo? ¿Qué pasa cuando te vas a la cama?». Mapee lo difícil: apagar la luz, el silencio, los pensamientos, los sueños. No interprete, solo levante el mapa.

2

Construcción del ritual (15 min)

Proponga: «Vamos a crear juntos un ritual de buenas noches que sea tuyo. Cada paso lo decidís vos». Constrúyalo con 4 o 5 pasos como máximo. Elementos que el niño puede elegir incluir: un momento para recordar al fallecido (mirar una foto, decirle buenas noches en voz alta o mentalmente); un objeto de transición que represente al fallecido (una remera, un juguete que era suyo); una respiración de tres tiempos (inspirar contando hasta 3, soltar contando hasta 3); una frase creada por el niño para repetir antes de dormir; un acuerdo con el progenitor sobreviviente sobre qué pasa si tiene una pesadilla.

3

Registro visual (5 min)

Dibuje el ritual en papel, cada etapa con un símbolo. El niño puede pegarlo en la pared del cuarto como ancla concreta para usar solo a la noche.

4

Orientación al progenitor sobreviviente

Es fundamental que el adulto cuidador conozca el ritual y lo sostenga en casa. La consistencia del ritual es lo que produce la sensación de seguridad. En una sesión de devolución con el familiar, explique su función y la importancia de mantenerlo incluso los días en que el adulto también está en duelo.

Lectura clínica

El objeto de transición elegido revela mucho: los niños que eligen objetos ligados al olor o la textura del fallecido buscan una experiencia sensorial de contacto, una forma primitiva y legítima de mantener la presencia. No lo sustituya prematuramente. Cuando el niño construye un ritual muy largo y rígido, puede indicar ansiedad generalizada usando el ritual como intento de control. Cuando se niega a crear cualquier ritual diciendo que «no sirve de nada», observe otros indicadores de depresión infantil asociada al duelo.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo son tus noches desde que [nombre] se fue?
- ¿Qué te pasa por la cabeza cuando estás en la cama a oscuras?
- ¿Tenés pesadillas? ¿Qué pasa en ellas?
- ¿Hay algo que te haga sentir más seguro a la noche?
- ¿Tenés algún objeto que te recuerde a [nombre] y que te gustaría tener cerca cuando dormís?

Adaptaciones

Para niños con TEPT tras una muerte violenta: el ritual debe incluir técnicas de regulación del sistema nervioso, respiración diafragmática y descenso de la activación fisiológica antes de dormir.

Para niños que compartían el cuarto con el fallecido: incluya en el ritual una forma de reappropriación del espacio físico, como reorganizar algo o crear un rincón especial.

TIPO	Juego estructurado de preguntas y respuestas con tarjetas
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Niño con creencias distorsionadas sobre la muerte, culpa mágica, confusión sobre la reversibilidad
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Tarjetas con afirmaciones: algunas verdaderas, algunas mitos. Preparar antes de la sesión.

Objetivo

Investigar y trabajar las creencias que el niño construyó sobre la muerte: distorsiones generadas por el pensamiento mágico infantil, por información inadecuada de los adultos, o por el intento de protegerlo con eufemismos como «se fue de viaje», «está durmiendo», «se convirtió en una estrellita». El problema de los eufemismos es que generan confusión cognitiva con consecuencias emocionales serias: el niño que cree que el padre «se fue de viaje» queda esperando el regreso; el que cree que «está en el cielo viéndote» puede sentirse vigilado y avergonzado. El formato de juego reduce la amenaza de abordar directamente la muerte y permite que el niño exprese sus creencias sin sentir que lo evalúan o corrigen.

Cómo aplicar

1

Preparación de las tarjetas (antes de la sesión)

Ejemplos de afirmaciones: «Cuando alguien muere, puede volver si rezamos mucho» — MITO. «La muerte es para siempre, la persona no vuelve más» — VERDAD. «Si me porté mal, puedo haber causado la muerte de alguien» — MITO. «Sentir enojo con quien murió es normal y no le hace mal» — VERDAD. «Pensar mucho en quien murió puede enfermarte» — MITO. «La añoranza puede doler mucho, pero no mata» — VERDAD. «Si me olvido de la persona, significa que no la quise lo suficiente» — MITO.

2

Aplicación en sesión (30 min)

Coloque las tarjetas mezcladas sobre la mesa. Proponga: «Voy a dar vuelta una tarjeta por vez. Vos me decís si te parece verdad o mito». No señale antes. Para cada tarjeta: el niño categoriza; usted pregunta «¿por qué te parece eso?»; recién después aborda la respuesta correcta sin tono de corrección, con curiosidad: «Es interesante lo que pensás sobre esto. Yo leí que...». Atención especial a las tarjetas en que el niño se equivoca con convicción.

Lectura clínica

La culpa mágica es el fenómeno más importante a rastrear. Los niños pequeños, hasta los 7 u 8 años, operan a menudo con el pensamiento preoperacional de que sus deseos y acciones tienen poder causal sobre la realidad. Un niño que peleó con el padre la semana en que él murió puede creer genuinamente que causó la muerte. Cuando la tarjeta sobre «portarse mal causa la muerte» se responde con certeza como verdad, deténgase ahí y profundice. La tarjeta sobre olvidar es especialmente importante: «si me olvido, no la quise lo suficiente». Cuando el niño la categoriza como verdad, revela una trampa común del duelo infantil: la creencia de que mantener el duelo activo es una prueba de amor, lo que puede impedir la inversión en nuevas relaciones y nuevas etapas de la vida.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué te parece que esta es verdad o mito?
- ¿Alguien ya te explicó cómo funciona la muerte?
- ¿Hay algo sobre la muerte de [nombre] que todavía no entendés?
- ¿Alguna vez pensaste que podrías haber hecho algo distinto para evitar que muriera?
- ¿Sentís que se puede recordar a una persona y aun así seguir con la vida?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: use solo 5 o 6 afirmaciones en lenguaje muy concreto.

Para familias con una fuerte creencia religiosa: adapte las tarjetas respetando la cosmología de la familia. Fe y negación son cosas distintas, y el trabajo es diferenciar una de la otra.

Para niños que revelan una culpa mágica intensa durante el juego: detenga el juego ahí y trabaje esa creencia específica en profundidad. El juego sirvió de diagnóstico.

TIPO	Actividad proyectiva de genograma adaptado con dibujo
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo con sentimiento de abandono, miedo a perder a otras personas, reorganización del sentido de pertenencia familiar
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande, marcadores de colores, lápices de colores

Objetivo

Trabajar el sentido de pertenencia y la red de apoyo del niño en duelo mediante una representación visual de la estructura familiar que contemple tanto a los que se fueron como a los que permanecen. Tras la muerte de un progenitor, muchos niños desarrollan ansiedad anticipatoria de pérdida: pasan a temer que otros miembros mueran, se apegan mucho al progenitor sobreviviente y se resisten a las separaciones. El árbol de la familia ancla concretamente quién está presente, cuáles son las relaciones de apoyo disponibles y dónde ocupa lugar todavía el fallecido, aunque sea simbólico, en la estructura familiar del niño.

Cómo aplicar

1

Presentación (3 min)

Entregue la hoja grande y diga: «Vamos a dibujar el árbol de tu familia. Cada persona va a ser una parte del árbol: rama, hoja, raíz, tronco, flor. Vos decidís qué es cada uno». No imponga una estructura. Deje que el niño organice como quiera.

2

Construcción del árbol (20 a 25 min)

El niño dibuja libremente. Pregunte por cada elemento: «¿Quién es este? ¿Por qué lo pusiste acá?». Observe quién queda cerca del tronco, quién en los bordes, a quién duda en incluir y, especialmente, dónde coloca al fallecido. Algunos lo ponen como raíz, otros como hoja que cayó, otros como estrella por encima del árbol. Cada representación tiene un significado clínico distinto.

3

La red de apoyo (10 min)

Al final pregunte: «Cuando estás triste o con miedo, ¿a qué parte de este árbol vas?». Esto identifica la figura de apoyo primaria disponible. Pregunte también: «¿Hay alguien en este árbol con quien todavía no podés hablar sobre [nombre]?». Esto mapea los bloqueos de comunicación sobre el duelo dentro de la familia.

Lectura clínica

La posición del fallecido en el árbol es el elemento más rico. Fallecido como raíz: el niño todavía ancla la estructura familiar en la figura perdida, lo que puede indicar dificultad para reconocer los vínculos que permanecen. Fallecido como hoja caída: representación integrada de la pérdida —la hoja fue parte del árbol y siempre lo será, pero cayó—. Fallecido como estrella fuera del árbol: distanciamiento o dificultad para integrar al fallecido a la narrativa familiar actual. Cuando el niño se coloca a sí mismo en una posición muy periférica o muy pequeña en el árbol, puede estar sintiéndose marginado en el sistema familiar, invisible en el duelo de los adultos o inseguro sobre su lugar en la familia reorganizada.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué elegiste poner a [nombre] en ese lugar del árbol?
- ¿A quién de este árbol buscás más cuando estás triste?
- ¿Hay alguien acá que te gustaría que estuviera más cerca?
- ¿Hay alguien con quien todavía no podés hablar sobre [nombre]?
- ¿Qué cambió en este árbol después de que [nombre] se fue?
- Si el árbol pudiera hablar, ¿qué diría sobre vos?

Adaptaciones

Para niños con familia reconstituida: incluya explícitamente la posibilidad de poner personas que «son familia aunque no sean de sangre». Ampliar el concepto de familia puede ser terapéutico en sí mismo.

Para niños con ansiedad anticipatoria intensa: use el árbol para una conversación directa sobre quién lo cuida y qué pasaría en distintos escenarios. Esto no aumenta el miedo, estructura el pensamiento ansioso.

TIPO	Actividad expresiva con arcilla o masa, recurso somático
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	Duelo somatizado, niño con quejas físicas sin causa orgánica, niño que no accede a las emociones por la vía verbal
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Arcilla o masa casera, superficie limpia

Objetivo

Acceder al contenido emocional del duelo por la vía sensorial y corporal, sorteando la barrera verbal que suele bloquear el proceso terapéutico con niños en duelo. La somatización es una de las formas más comunes de expresión del duelo infantil no elaborado: dolores de panza, de cabeza, cansancio inexplicable, falta de apetito. Al trabajar con arcilla, el niño accede a un canal sensorial y motor que evita las defensas cognitivas y permite que el contenido emocional emerja de forma más directa. El producto final de la escultura no es el objetivo: el proceso de hacerla es el recurso terapéutico.

Cómo aplicar

- 1 Calentamiento sensorial (5 min)**
Entregue la arcilla y deje que el niño explore libremente: amasar, golpear, estirar, enrollar. No proponga nada todavía. Ese contacto sensorial inicial es regulador. Observe la calidad del contacto: un niño que golpea con fuerza puede estar descargando enojo; uno que moldea con cuidado está en un estado más reflexivo.
- 2 La propuesta de modelado (5 min)**
Tras el calentamiento, proponga una de tres consignas según el momento clínico. Opción A, para duelo reciente: «¿Podés modelar lo que sentís cuando pensás en [nombre]? Puede ser una forma, un peso, una textura que represente ese sentimiento». Opción B, para niños con quejas somáticas: «¿Dónde en tu cuerpo sentís ese dolor? ¿Podés modelar cómo es ese dolor por dentro?». Opción C, para la fase de resignificación: «¿Podés modelar algo que represente lo que quedó dentro tuyo de [nombre]?».
- 3 Modelado acompañado (20 min)**
Quédese presente mientras el niño trabaja. Pregunte ocasionalmente sin interrumpir el flujo. Si quiere, modele usted también algo a su lado: eso iguala la relación y reduce la asimetría.
- 4 Narrativa de la escultura (10 min)**
Cuando termine, invite: «Contame qué hiciste». No interprete la escultura por él. Haga preguntas abiertas sobre qué es cada parte, qué quiere decir la escultura, si tiene un nombre, si necesita algo.

Lectura clínica

La calidad del trabajo con la arcilla es una ventana al estado emocional. Arcilla muy amasada o destruida puede representar enojo o impotencia. Arcilla cuidadosamente modelada en formas delicadas indica un intento de control del material emocional. Un niño que modela una figura humana y después la destruye revela algo sobre su proceso de duelo: pregunte «¿Qué le pasó? ¿Cómo te sentiste al destruirla?». Las esculturas que el niño nombra con el nombre del fallecido y guarda con cuidado extremo pueden revelar la necesidad de un objeto transicional concreto. Evalúe con la familia si tiene sentido que el niño la lleve a casa o si permanece en el consultorio.

Preguntas orientadoras

- Contame qué modelaste. ¿Qué es cada parte?
- Si esta escultura pudiera hacer un sonido, ¿cuál sería?
- ¿Hay algún lugar de tu cuerpo donde sentís el duelo más fuerte?
- Si pudieras transformar esta escultura en otra cosa, ¿qué harías?
- ¿Esta escultura necesita algo? ¿Qué te pide?

Adaptaciones

Para niños que rechazan el contacto con la arcilla: reemplácela por harina con agua o por papel amasado. Lo importante es el contacto con un material maleable y la posibilidad de destruir y reconstruir.

Para niños con quejas somáticas frecuentes: pídales que hagan primero un mapa corporal marcando dónde sienten el dolor, y después modelen en arcilla la forma de ese dolor. La doble representación, visual y táctil, es especialmente potente.

TIPO	Creación de una historia terapéutica por el niño — narrativa proyectiva
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo con narrativas de culpa, vergüenza, narrativas familiares silenciosas o distorsionadas sobre la muerte
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hojas en blanco, marcadores, lápices de colores

Objetivo

Acceder y trabajar la narrativa interna que el niño construyó sobre la muerte, porque todo niño construye una historia explicativa sobre lo que pasó, y esa historia rara vez se cuenta en voz alta. Cuando la narrativa interna es distorsionada —como «mi papá murió porque yo era un mal hijo»—, opera silenciosamente como organizadora de la identidad y como obstáculo al proceso de duelo. El recurso propone que el niño cree una historia con personajes ficticios que viven una situación de pérdida. La distancia del personaje permite acceder al contenido sin el peso de la exposición directa. La historia que el niño inventa dice mucho sobre la historia que vive.

Cómo aplicar

1

La invitación (5 min)

Diga: «Vamos a inventar una historia juntos. La historia tiene un personaje —puede ser un animal, un niño, un héroe, lo que quieras— y ese personaje perdió a alguien muy importante para él. A partir de ahí, vos creás cómo sigue la historia». Deje que el niño elija el personaje, el tipo de pérdida y el contexto.

2

Construcción colaborativa (25 min)

El niño crea la historia y usted acompaña con preguntas que profundizan temas clínicamente relevantes. No dirija la trama. Pregunte: «¿Y cómo se sintió el personaje cuando se enteró?», «¿Qué hicieron las otras personas alrededor?», «¿Le contó a alguien lo que estaba sintiendo?», «¿Qué creyó que había hecho mal?», «¿Cómo termina la historia?». Si se traba, proponga un rumbo en forma de pregunta: «¿Qué te parece que podría pasar ahora?».

3

El giro (5 min)

Cuando la historia llegue al punto de mayor dolor, proponga: «¿Qué necesitaría el personaje que pasara ahora para poder atravesar esto?». La respuesta revela lo que el propio niño está necesitando: de quién, de qué forma, con qué calidad de presencia.

4

El puente a la vida real (5 min)

Al final, tienda el puente con cuidado: «Esta historia que inventaste me hizo pensar en vos. ¿Hay algo de lo que le pasó al personaje que se parece a lo que estás viviendo?». El niño puede hacer o no la conexión. Ambas respuestas son válidas.

Lectura clínica

Las historias que inventan los niños tienden a repetir patrones de la propia narrativa interna. Personajes culpables de la pérdida, personajes que concluyen que no son queribles, personajes que quedan solos sin nadie que los ayude: esas tramas señalan las creencias nucleares que el niño carga sobre sí mismo en relación con el duelo. Observe el final de la historia. Finales abruptos sin resolución, o historias que terminan con la muerte del personaje principal, pueden indicar desesperanza. La figura que el niño coloca como apoyo del personaje revela quién siente que podría ser su sostén real. Si el personaje no tiene a nadie, eso es un dato clínico urgente sobre el aislamiento del niño en el duelo.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué elegiste ese personaje? ¿Tiene algo que te recuerde a alguien?
- ¿Qué cree el personaje que hizo mal?
- ¿Hay alguien en la historia que ayuda al personaje? ¿Quién es?
- ¿Qué necesitaría escuchar el personaje para poder seguir adelante?
- ¿Hay alguna parte de esta historia que se parezca a tu vida?

Adaptaciones

Para niños muy resistentes a la ficción que dicen «no quiero inventar, quiero hablar de verdad»: acéptelo. Ese pedido de autenticidad significa que el niño está listo para acceder al contenido directamente. Cambie a un recurso más directo.

Para niños muy pequeños (4 a 6 años): usted empieza la historia —«había una vez un cachorro de león que perdió a su mamá»— y el niño dicta qué pasa después.

TIPO	Actividad expresiva con collage, papel rasgado y dibujo — foco en enojo y frustración
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo con enojo no expresado: enojo con el fallecido, con el progenitor sobreviviente, con Dios, con la situación
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande A3 o papel kraft, revistas viejas para rasgar, marcadores, lápiz rojo y negro, cola

Objetivo

Ofrecer un canal expresivo estructurado para el enojo en el duelo, una de las emociones más silenciadas y menos acogidas del proceso de duelo infantil. El enojo con el muerto se considera socialmente inadmisibles: «no se puede tener enojo con quien murió», «deberías estar extrañándolo, no enojado». Esa interdicción fuerza el enojo hacia adentro, donde se expresa por vías indirectas: comportamiento agresivo, explosiones sin causa aparente, dificultades escolares, somatización. El panel del enojo crea un espacio explícitamente permitido para que ese afecto emerja, sea nombrado y externalizado sin causar daño. El uso de papel rasgado y collage introduce el elemento físico-motor esencial: el enojo es una emoción de alta activación y necesita un canal corporal, no solo verbal.

Cómo aplicar

1

Normalización del enojo (5 min)

Antes de proponer cualquier actividad, tenga una conversación directa: «Cuando perdemos a alguien, la gente habla mucho de la tristeza y la añoranza. Pero casi nadie dice que también da enojo. Enojo con quien se fue. Enojo con Dios. Enojo con quien quedó. Enojo con toda la situación. Eso es muy normal. Hoy vamos a crear un lugar para que ese enojo salga». Observe la reacción: si el niño se afloja, el enojo estaba represado.

2

Creación del panel (20 a 25 min)

Ponga a disposición todos los materiales. Diga: «Este panel es el lugar del enojo. Podés rasgar, pegar, escribir, tachar, arrugar. No hay nada que no puedas poner acá». Si duda al principio, demuéstrela usted: rasgue un pedazo de revista, péguelo, garabatee con fuerza. El modelado del terapeuta rompe la inhibición. Permanezca presente sin interpretar en voz alta.

3

Nombramiento del enojo (10 min)

Cuando el panel esté listo, pregunte: «¿Qué hay acá? Contame». Pregunte: «¿Para quién es este enojo?» y «¿Qué está diciendo este enojo?».

4

Qué hacer con el enojo (5 min)

Pregunte qué quiere hacer el niño con el panel: guardarlo, destruirlo, llevarlo a casa. No proponga destruirlo si el niño no lo propuso. Algunos construyen y después quieren rasgar todo, lo cual es catártico y puede permitirse con conciencia.

Lectura clínica

La intensidad física con que el niño trabaja el panel es el primer dato clínico. Un niño que rasga papel con fuerza está descargando enojo acumulado: es el proceso terapéutico ocurriendo en tiempo real. Un niño que trabaja con exceso de cuidado en el «panel del enojo» puede estar aún inhibido; normalícelo: «Puede ser más bravo que esto». Observe hacia quién se dirige el enojo. El enojo con el fallecido por haber muerto es sano y frecuente. El enojo con el progenitor sobreviviente puede revelar que el adulto no está lo suficientemente presente en lo emocional. El enojo con Dios o con la vida es un enojo existencial, profundo, legítimo, que debe acogerse sin intento de resolución inmediata. Cuando el enojo se dirige hacia el propio niño —culpa disfrazada de enojo—, hay que identificarlo y trabajarlo directamente.

Preguntas orientadoras

- ¿Para quién es este enojo?
- ¿Qué quiere decir tu enojo? ¿Qué está pidiendo?
- ¿Sabías que se puede tener enojo con alguien que querés al mismo tiempo?
- Cuando sentís ese enojo, ¿qué solés hacer con él?
- ¿Hay algún enojo que todavía no pusiste en el panel y que está guardado?
- ¿Qué pasa cuando dejás salir el enojo?

Adaptaciones

Para niños con comportamiento agresivo explícito: el panel está especialmente indicado, pero debe acompañarse de una conversación sobre canales seguros. «El enojo puede salir acá, en el papel. Lo que no puede es salir pegándole a las personas».

Para niños que niegan cualquier enojo y se muestran excesivamente «buenitos»: proponga que el panel sea «de cualquier sentimiento», no específicamente del enojo. El enojo puede emerger en el proceso sin ser nombrado de antemano.

Para duelo por suicidio: el enojo tiende a ser especialmente intenso y silenciado por culpa y vergüenza social. El panel puede ser el primer espacio en que ese enojo recibe permiso.

TIPO	Protocolo de orientación parental — sesión con el responsable
EDAD	Padres y responsables de niños de 4 a 10 años
DEMANDA	Complemento del trabajo con el niño siempre que el ambiente familiar se identifique como factor de riesgo o de apoyo insuficiente
DURACIÓN	50 a 60 minutos — sesión exclusiva con el adulto, sin el niño
MATERIALES	Ninguno específico. Eventualmente un guion impreso de orientaciones para llevar a casa.

Objetivo

El duelo del niño no ocurre en el vacío: está profundamente modulado por cómo el ambiente familiar maneja la pérdida. El progenitor sobreviviente es, a la vez, la figura de apoyo más importante para el niño y, por lo general, la persona más destrozada por el mismo evento. Esa asimetría —el adulto que más puede ayudar es el que más necesita ayuda— es una de las grandes complejidades del duelo parental infantil. Este recurso ofrece un protocolo de orientación para sesiones con el adulto cuidador, enfocado en traducir a lenguaje cotidiano qué necesita el niño, qué está presentando y cómo el adulto puede ser presencia de apoyo aun estando él mismo en duelo. Importante: esta sesión no es terapia para el adulto, es orientación clínica. Si el adulto necesita apoyo psicológico, déVELO a atención individual propia.

Cómo aplicar

1

Bloque 1 — Cómo está el niño: traducción clínica (15 min)

Comparta, con cuidado y con la autorización implícita o explícita del niño, cómo está llegando a las sesiones, sin revelar contenidos que él pidió mantener en secreto. Use el lenguaje del desarrollo. Traducciones útiles para el adulto: regresión conductual (hacerse pis en la cama, lenguaje infantilizado); búsqueda de seguridad y de ser cuidado; agresividad: enojo que no tiene un canal de salida adecuado; «estoy bien» sin ninguna expresión de tristeza: duelo inhibido por un mensaje implícito de que no es seguro sufrir; quejas físicas sin causa orgánica: somatización del duelo; hiperapego al progenitor sobreviviente: ansiedad anticipatoria de una nueva pérdida.

2

Bloque 2 — Qué necesita el niño del adulto: orientaciones concretas (20 min)

Ejemplos de orientaciones específicas y prácticas: «Cuando venga con una pregunta sobre la muerte, no cambie de tema. Responda con honestidad y lenguaje simple, aunque sea difícil». «Mantenga la rutina lo más posible. Escuela, hora de dormir, cenar juntos: la previsibilidad es un ancla de seguridad». «Permita que lo vea triste. Cuando el adulto esconde todo, el niño aprende que el duelo también debe esconderse». «No use el nombre del fallecido como amenaza ni comparación: eso carga una culpa innecesaria». «Permita que diga el nombre del fallecido, cuente historias, mire fotos. Eso es elaboración, no negación».

Bloque 3 — Qué necesita el adulto: escucha y derivación (15 min)

Reserve un espacio para escuchar brevemente cómo está el adulto. Si identifica un sufrimiento intenso sin apoyo, haga la derivación a atención individual. Sea directo y sin culpabilizar: «Vos también estás pasando por algo muy difícil. Merecés tener a alguien que te cuide a vos también, no solo ser el apoyo de todos».

Lectura clínica

Observe la capacidad de mentalización del adulto respecto del niño: si logra pensar sobre lo que él está sintiendo, o si está tan inmerso en su propio duelo que perdió temporalmente el acceso a la perspectiva del niño. Cuando la mentalización está comprometida, el adulto tiende a interpretar el comportamiento difícil del niño como «berrinche» o «maldad», lo que aumenta el aislamiento del niño en el duelo. Observe cómo habla el adulto del fallecido: adultos que no logran mencionar el nombre, que cambian de tema, o que idealizan al muerto de un modo que no permite ninguna ambivalencia, están transmitiendo mensajes implícitos muy poderosos sobre cómo debe vivirse el duelo.

Preguntas orientadoras para el adulto

- ¿Cómo están pudiendo hablar de [nombre] en casa?
- ¿El niño hace preguntas sobre la muerte? ¿Qué le responden?
- ¿Logran darse cuenta de cuándo está triste, o generalmente dice que está bien?
- ¿Hay algo que el niño hace que no saben cómo manejar?
- ¿Tienen algún apoyo para ustedes mismos en este momento?

Adaptaciones

Para familias en las que el duelo está siendo silenciado activamente: el trabajo con el adulto es tan urgente como el trabajo con el niño. Considere sesiones de orientación más frecuentes antes de que el silencio se consolide como patrón.

Para situaciones en que el progenitor sobreviviente está en duelo complicado: sea directivo en la derivación. El adulto no necesita estar curado para ayudar al niño, pero necesita tener su propio apoyo para que el cuidado no quede completamente solitario.

TIPO	Ritual de cierre terapéutico — actividad de síntesis y celebración del proceso
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Fase final del acompañamiento, cuando hay indicadores de elaboración y el alta se aproxima
DURACIÓN	50 a 60 minutos
MATERIALES	Todos los materiales producidos a lo largo del acompañamiento, hoja nueva, marcadores

Objetivo

Crear un ritual de cierre del proceso terapéutico que sea a la vez una síntesis del camino recorrido y una celebración de la elaboración conquistada. El cierre de un acompañamiento de duelo es, en sí mismo, una experiencia de pérdida: el niño pierde la relación terapéutica, el espacio seguro, el ritual semanal que organizó el duelo. Cuando no hay ritual de cierre, el alta puede reactivar la experiencia de abandono que es central al duelo. Este recurso transforma el cierre en un acto de integración: el niño mira todo lo que produjo a lo largo del proceso, nombra lo que cambió y se va llevando consigo una síntesis de lo que aprendió. Debe proponerse solo cuando hay indicadores clínicos reales de elaboración, no por presión de plazo. Indicadores de que el proceso está listo para cerrar: el niño logra hablar del fallecido con afecto y sin desorganizarse; retomó la inversión en el juego, las amistades y la escuela; los síntomas iniciales remitieron; muestra una comprensión integrada de la permanencia de la muerte.

Cómo aplicar

1

Preparación y anticipación (en la sesión previa al cierre)

Anuncie el cierre con al menos dos sesiones de anticipación: «Estamos llegando cerca del final de nuestro trabajo juntos. En dos semanas va a ser nuestra última sesión por ahora». Esto le da tiempo al niño para procesar la noticia y traer lo que surja.

2

Revisión del recorrido (20 min)

En la sesión final, organice sobre la mesa todo lo producido durante el acompañamiento: la caja de recuerdos, el mapa de la añoranza, las cartas, el diario, el libro del fallecido, el termómetro completado, los paneles, las esculturas. Para cada material pregunte: «¿Qué te acordás de cuando hicimos esto?» y «¿Qué significa este material para vos ahora?». Deje que el niño lidere el ritmo de la revisión.

3

La hoja de lo que aprendí (15 min)

Proponga una hoja nueva: «¿Qué aprendiste sobre vos mismo en este tiempo que estuvimos acá juntos?». No dirija. El contenido de esta hoja suele ser sorprendente: los niños nombran aprendizajes que el terapeuta no anticipó.

Ritual de despedida (10 min)

Proponga un gesto simbólico de cierre que tenga significado para el niño: un apretón de manos especial, una última entrada en el diario, una frase que cada uno le dice al otro. Deje que el niño elija el gesto. Al final, diga directamente: «Fue un honor acompañarte en este camino». Aclare que la puerta no se cierra: «Si en algún momento querés volver, podés». Esto es especialmente importante para niños en duelo que ya vivieron una pérdida irreversible.

Lectura clínica

Observe la reacción del niño al anuncio del cierre en la sesión previa. Un niño que se pone ansioso o regresa levemente no está manipulando: está mostrando que la relación terapéutica tiene importancia y que la separación activa, legítimamente, la experiencia de pérdida. Eso merece elaboración en las sesiones de cierre. Lo que el niño elige llevar a casa es clínicamente significativo: el que se lleva la caja de recuerdos y el libro del fallecido está integrando el duelo en su narrativa de vida. La hoja de «lo que aprendí» puede guardarla el terapeuta como registro del cierre; si el niño regresa en el futuro, cuando el duelo se reactive en otra fase del desarrollo, ese documento es un punto de retomada del recorrido.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué cambió en vos desde que empezamos a trabajar juntos?
- ¿Hay algún momento de nuestras sesiones que nunca vayas a olvidar?
- ¿Cómo estás ahora en relación con [nombre]? ¿Qué es distinto del comienzo?
- ¿Qué vas a hacer cuando sientas la añoranza ahora, sin la sesión?
- ¿Hay algo que todavía te hubiera gustado trabajar y no trabajamos?
- ¿Qué te gustaría decirme antes de despedirnos?

Adaptaciones

Para niños que hicieron pocos materiales a lo largo del proceso (proceso muy verbal, sin registros): reemplace la revisión de materiales por una conversación guiada sobre las sesiones más marcantes.

Para niños cuyo duelo probablemente se reactive en fases futuras (adolescencia, casamiento, nacimiento de hijos): nómbrelo explícitamente. «Es normal que el duelo vuelva en momentos importantes de tu vida. Cuando eso pase, significa que estás creciendo. Y ya tenés herramientas para atravesarlo».

Para procesos interrumpidos por cambio de terapeuta o factores externos: nómbrelo directamente. «No terminamos porque estaba todo listo. Paramos acá por ahora, y eso también es difícil».